

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

ESCUELA DE POSGRADO



**LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS
PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA
METROPOLITANA - LIMA 2025**

**PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN:
GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL**

**PRESENTADO POR TITULADO
KATHERINE SUSAN RUFASTO GOCHE**

LIMA – PERÚ

2025

ÍNDICE

Portada

Índice

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	N° de Pág.
1.1 Descripción de la realidad problemática	4
1.1.1 Formulación del problema	4
1.1.2 Problema general	6
1.1.3 Problemas específicos	6
1.2 Objetivos de la investigación	7
1.2.1 Objetivo general	7
1.2.2 Objetivos específicos	7
1.3 Justificación e importancia de la investigación	8
1.3.1 Justificación	8
1.3.2 Importancia	9
1.4 Limitaciones en la Investigación	9
1.5 Delimitación del área de Investigación	10
CAPÍTULO II: MARCO TEORICO	
2.1 Antecedentes de la investigación	11
2.2 Marco conceptual	17
2.3 Glosario de términos	25
2.4 Formulación de la hipótesis	27
2.4.1 Hipótesis general	27
2.4.2 Hipótesis específicas	27
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	
3.1 Aspectos metodológicos	29
3.1.1 Tipo y Diseño de investigación	29
3.1.2 Identificación de variables	30
3.1.3 Operacionalización de variables	32
3.2 Población y muestra	34
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	35
3.3.1 Técnicas	35
3.3.2 Instrumentos	36
3.4 Procesamiento de la información.	36
3.5 Aspectos éticos	38
CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	39
4.1. Cronograma de ejecución	39
4.2. Presupuesto	41
FUENTES DE INFORMACIÓN	42
• Referencias bibliográficas	42
ANEXOS	49
ANEXO N° 1 Matriz de consistencia	49
ANEXO N° 2 Instrumento	50
ANEXO N° 3 Validación de instrumento/expertos	52
ANEXO N° 4 Consentimiento Informado	55

INTRODUCCIÓN

En el entorno actual de la atención en salud pública en el Perú, la percepción de los pacientes sobre la calidad del servicio que reciben se ha convertido en un tema central para la mejora continua de los establecimientos sanitarios. A pesar de los planteamientos del Estado para una ampliación de la cobertura y mejorar los servicios, aún persisten situaciones que generan insatisfacción, como la falta de personal, los tiempos de espera prolongados, una infraestructura limitada y una atención que muchas veces no responde con calidez ni eficacia a las necesidades del paciente.

Entonces, estas deficiencias además de afectar el bienestar de los pacientes debilitan su confianza y reducen la probabilidad de que decidan regresar para futuras atenciones.

En este contexto, comprender la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los usuarios resulta esencial para diseñar estrategias de mejora desde una perspectiva en la experiencia del paciente. Este estudio se propone investigar esta relación en un centro de salud público de Lima Metropolitana. A través de un enfoque cuantitativo, se busca recoger evidencia directa, permitiendo identificar aspectos críticos que requieren atención prioritaria.

La importancia de este trabajo radica en su potencial para la generación de propuestas concretas de mejora, con base en la percepción de los pacientes. Al reconocer los factores que más valoran los usuarios y aquellos que generan mayor descontento, se podrán tomar decisiones acertadas y humanizadas, fortaleciendo así la calidad de atención en los centros de salud públicos del país.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

1.1.1 Formulación del problema

La calidad del servicio en los centros de salud públicos sigue siendo un tema crítico por su impacto en relación con la forma en que los pacientes perciben y se sienten con la atención proporcionada. Pese a los avances, persisten problemas en el trato al usuario, la respuesta del personal, la infraestructura y la comunicación. Esto genera insatisfacción y desconfianza, lo que reduce la intención de los pacientes de volver a atenderse en estos establecimientos.

A nivel internacional, estudios en la India, indican sobre la experiencia del paciente que puede variar según aspectos tangibles de la atención, así como por las brechas de comunicación y los retrasos en el servicio. Por otro lado, la integración de la tecnología ha revolucionado la oferta de cuidados sanitarios. Aun así, esta adopción de tecnología en el sector sanitario enfrenta múltiples barreras. En particular, los gastos significativos de implementación, el apego a lo rutinario y la pérdida de competitividad siguen siendo obstáculos importantes (Razeena, & Shareena, 2025).

Asimismo, en países como Bangladesh, India y China, la satisfacción de los pacientes con enfermedades crónicas muestra diferencias notables. En Bangladesh, el 70,5 % de mujeres se mostró conforme con el sistema de salud, frente al 41,7 % en India y 61,3 % en China. Entre los hombres, el descontento fue mayor: 54,5 % en Bangladesh, 42,8 % en India y 58,8 % en China. Estas cifras evidencian percepciones críticas sobre la calidad del sistema sanitario, especialmente en India (Calle, 2023).

En América Latina, aún existen pocas propuestas nacionales de políticas públicas de salud que aborden integralmente el reto de la calidad (Dávila & Chirinos, 2022). En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), argumenta que existen causas que deterioran la calidad de atención. En el sector salud, estos problemas se relacionan con la oferta limitada de servicios disponibles, sumada a una elevada demanda no atendida por parte de la población que requiere atención médica (Espinoza, 2022).

En el Perú, MINSA (2012) reporta que, frente al incremento constante de la demanda en los establecimientos de salud, se ha evidenciado un aumento en los niveles de insatisfacción de los pacientes, lo que hace indispensable incorporar metodologías alternativas que permitan obtener resultados para la toma de decisiones en el proceso de mejora en la calidad de la atención brindada.

Asimismo, el sistema de salud enfrenta limitaciones en el abastecimiento a los establecimientos públicos, lo que dificulta la prestación de una atención de calidad y la satisfacción del usuario. Además, la escasez de personal de salud agrava esta problemática, especialmente en los centros ubicados en zonas de extrema pobreza, donde la atención deficiente es aún más evidente (Arce & Aliaga, 2023).

En el contexto peruano, el servicio ambulatorio del área de Medicina Interna en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, ubicado en la ciudad de Huancayo, 60,3 % de los usuarios se declaró satisfecho con la eficiencia en la atención. Las áreas mejor valoradas fueron garantía y comprensión del personal, mientras que los aspectos tangibles (infraestructura, comodidad, orientación al usuario, etc.) concentraron la mayor proporción de insatisfacción.

En la prestación de emergencias perteneciente a un establecimiento del sistema de seguridad social, los pacientes en un 64,2 % estuvo insatisfecho, sobre todo por deficiencias en comodidad y orientación, pese a buena confiabilidad y

capacidad de respuesta. Otro reporte mostró casi 90 % de insatisfacción general, con problemas marcados en confiabilidad y seguridad, en una institución privada de Huancayo se observaron resultados similares. La evidencia sugiere que se requieren estrategias integrales de mejora de calidad, orientadas tanto a la percepción del paciente como a resultados objetivos en salud (Febres & Mercado, 2020).

La cobertura brindada en las unidades de salud públicas del Perú refleja una problemática persistente tomando en cuenta el estándar de atención proporcionado a la población.

Estos establecimientos enfrentan limitaciones significativas: escasez de personal, tiempos prolongados de espera, infraestructura deficiente y una atención poco empática. Resulta preocupante que la población, en especial la más vulnerable, deba conformarse con un servicio que no siempre garantiza calidad en la atención. Esta situación, se repite a nivel nacional y contribuye a la creciente insatisfacción del usuario.

1.1.2 Problema general

¿Qué relación existe entre la calidad del servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?

1.1.3 Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?
- ¿Cuál es la relación entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?
- ¿Cuál es la relación entre la capacidad de respuesta del personal médico-administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?

- ¿Cuál es la relación entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?
- ¿Cuál es la relación entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?

1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo general

Determinar la relación que existe entre la calidad del servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

1.2.2 Objetivos específicos

- Determinar la relación entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.
- Determinar la relación entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.
- Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del personal médico-administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.
- Determinar la relación entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.
- Determinar la relación entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

1.3. Justificación e importancia de la investigación

1.3.1 Justificación

Justificación Teórica

Esta investigación busca generar una reflexión acerca del nivel de conocimiento existente respecto a la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios en los centros de atención pública en salud. Aunque se han desarrollado teorías y modelos sobre cómo influyen estos factores en la conducta del usuario, muchos de esos estudios han sido aplicados en contextos privados o internacionales. Se generará una reflexión crítica sobre las teorías existentes con datos reales. Esta revisión enriquecerá el conocimiento disponible, asimismo abrirá nuevas formas de entender la experiencia del usuario en salud pública.

Justificación Metodológica

La investigación plantea una metodología concisa que puede ser aplicada en otros estudios similares. Se propone el enfoque cuantitativo, que permite recolectar datos objetivos y analizarlos de forma precisa. Además, se indica el uso de encuesta estructurada como herramienta principal, la cual será validada previamente para asegurar una medición correcta. También se contempla el uso de técnicas estadísticas para interpretar los resultados, como análisis descriptivos y correlaciones, lo que permitirá identificar patrones y relaciones entre las variables estudiadas.

Justificación Práctica

La investigación pretende explicar cómo influye la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en el centro de salud objeto de estudio. Al identificar estas relaciones, las mismas servirán de base para proponer estrategias, para mejorar la experiencia del paciente y fomentar su retorno.

Además, el estudio busca ofrecer recomendaciones concretas basadas en los resultados obtenidos, que sirvan como guía para la gestión en el centro de salud.

1.3.2 Importancia

Esta investigación es importante porque aborda un aspecto fundamental en el sistema de salud pública que es la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio que reciben en los centros de salud. Entender cómo esta percepción influye en su satisfacción y en la decisión de volver al establecimiento permite mejorar la atención y fortalecer la confianza en los servicios públicos. Esta investigación sirve para identificar cuáles son los factores que más valoran los pacientes al momento de recibir atención médica, y cómo estos aspectos impactan en su experiencia general. Quiénes se beneficiarán directamente con los resultados serán los pacientes, ya que se podrán implementar mejoras en los servicios que usan con frecuencia. También se beneficiarán los profesionales de salud y los gestores en salud, quienes podrán aplicar estrategias para mejorar la calidad del servicio y lograr una mayor fidelización del usuario. Los resultados se usarán como base para tomar decisiones informadas, especialmente en áreas como atención al cliente, organización interna y formación del personal. A partir de este trabajo, podrían surgir nuevas ideas y recomendaciones para futuras investigaciones que quieran profundizar en temas relacionados, como la experiencia del paciente

1.4 Limitaciones de la investigación

Durante el trabajo investigativo podrían surgir factores externos que limiten su alcance. Una posible limitación es la disposición de los pacientes para participar en las encuestas, ya que algunos pueden negarse por falta de tiempo, desinterés o desconfianza.

1.5 Delimitación del área de investigación

El análisis propuesto se realizará dentro del Centro de Salud de Breña, ubicado en Jirón Napo 1445, Lima, Perú. Los resultados estarán centrados en esta zona y realidad específica.

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes Nacionales

Chávez & Bueno (2024), desarrollaron la investigación *Assessing Public Service Quality and User Satisfaction: A Case Study of the District Municipality of San Luis, Peru (Cañete, Perú)*, la meta del estudio fue establecer la asociación entre las variables desde la perspectiva de los usuarios. La investigación fue aplicada, analítica y comparativa, diseño no experimental y de naturaleza transversal. Se procedió a la aplicación de un formulario de 47 preguntas a la muestra de 382 usuarios. Los resultados evidenciaron una relación directa y de intensidad moderada entre la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los usuarios, sustentada en un coeficiente Rho de Spearman de 0.415, con un nivel de significancia bilateral de 0.000.

Córdova et al. (2024) analizaron el estudio *Calidad de servicio en un hospital del nivel II para la satisfacción del paciente en el Perú* (Lima, Perú). La investigación tuvo como objetivo examinar la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción del paciente. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y un nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 300 usuarios seleccionados aleatoriamente. Los hallazgos evidenciaron una relación significativa entre la calidad del servicio y el grado de satisfacción hospitalaria al obtenerse un Beta = 0.760 y un $R^2 = 0.577$, existió, entonces, una fuerte correlación positiva. El modelo de regresión estructural con *Analysis of Moment Structures* (AMOS), cuantificó el nivel de dependencia entre ambas dimensiones inferidas y el valor obtenido (0.76) representó una fuerte asociación directa. Aproximadamente el 57.7% de la variabilidad en la satisfacción de los pacientes se explicó por la calidad del servicio ofrecido en el hospital. Este hallazgo reforzó que la calidad del

servicio fue un predictor clave de la satisfacción hospitalaria en el contexto evaluado.

Arce & Aliaga (2023) plantearon la pesquisa titulada Calidad de atención y satisfacción del usuario en un Servicio de Emergencia de un Hospital del Seguro Social (Ica, Perú), tuvo como propósito establecer la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario en dicho contexto. El estudio adoptó un diseño analítico de tipo transversal, aplicándose a una muestra de 400 pacientes atendidos en un servicio de emergencia del Seguro Social en la región sur del país. Los resultados, obtenidos a través del coeficiente Rho de Spearman (0.8590) con un nivel de significancia $p < 0.05$, evidenciaron una relación positiva moderada y estadísticamente significativa entre ambas variables.

Romero et al. (2023) desarrollaron una investigación denominada *Service quality and institutional image as predictors of customer satisfaction in municipalities of Perú. Journal of Law and Sustainable Development* (Perú). Esta investigación tuvo como objetivo examinar en qué medida la calidad del servicio y la imagen institucional permiten anticipar o explicar el nivel de satisfacción del cliente en los municipios del Perú. Se basó en un enfoque cuantitativo, prospectivo y correlacional, con una muestra de 352 usuarios de los municipios del Perú y se empleó una encuesta para recopilar información. En los resultados se obtuvo un R^2 de 0.460, lo que se explica porque el 46% de la satisfacción del usuario puede ser predicha por dos factores: la calidad del servicio y la imagen institucional en los municipios del Perú. De estos dos, la calidad del servicio fue el factor más influyente, con un coeficiente beta de 0.654, lo que indica que tiene un mayor impacto en la satisfacción de los usuarios que la identidad institucional. Además, el modelo de Cohen para regresión múltiple mostró un tamaño del efecto de 0.851, considerado muy alto, lo que significa que la influencia de estas variables en la satisfacción es fuerte. Se concluyó que la calidad del servicio influye fuertemente en la satisfacción del cliente en los municipios del Perú.

Silva Juárez et al. (2021) en su estudio titulado *Calidad del servicio y su relación con la satisfacción del cliente: Empresas turísticas de Canchaque-Perú* (Piura). La investigación tuvo como finalidad identificar la relación existente entre la calidad del servicio ofrecido por empresas turística, como hospedajes, restaurantes y medios de transporte, además de la satisfacción del cliente en el distrito de Canchaque, ubicado en la región de Piura. Dado el carácter de las variables, el estudio se enmarcó en un diseño no experimental, transversal, con un enfoque cuantitativo y nivel correlacional. La evaluación de la calidad del servicio se basó en las dimensiones del modelo ServQual, mientras que la satisfacción del cliente fue medida mediante una perspectiva unidimensional, que considera la satisfacción del cliente como una sola dimensión (percepción general del servicio recibido). Sobre los resultados, solo los hospedajes presentaron una correlación suficientemente fuerte y significativa ($r = 0.349$; $p < 0.05$) para afirmar que la calidad del servicio influye positivamente en la satisfacción del cliente. En cambio, restaurantes y medios de transporte no evidenciaron correlaciones prácticas importantes, especialmente el primero, cuyo resultado no fue estadísticamente significativo ($p > 0.05$). La estimación relacionada con los servicios de alojamiento, restauración y traslado se complementa con los promedios obtenidos en las encuestas, los cuales reflejan la percepción directa de los usuarios. En particular, los servicios de transporte muestran calificaciones bajas en todas las dimensiones evaluadas, con un promedio general que evidencia una percepción negativa. En las conclusiones se menciona que los servicios ofrecidos por los hospedajes turísticos cumplen con estándares de calidad, mientras que los restaurantes evidencian tanto fortalezas como debilidades en su atención, y la prestación del servicio en el sector transporte resulta limitada y poco eficiente.

2.1.2 Antecedentes Internacionales

Villanueva et al. (2025) efectuaron una investigación bajo el título de: *Service Quality and Customer Satisfaction Among Coffee Shops in*

Dumaguete City, Philippines (Dumaguete, Filipinas). Los objetivos fueron comprender la dinámica de la eficiencia en la atención y la respuesta favorable del usuario. La investigación utilizó un diseño descriptivo-correlacional para obtener información de los clientes que visitaron las cafeterías seleccionadas. Un total de 120 encuestados fueron clientes, lo que comprendió el tamaño de la muestra de esta investigación. Los resultados se presentaron como p-valores y se confirmó una correlación estadísticamente significativa ($p < 0.05$) entre el desempeño del servicio y el grado de conformidad del usuario (coeficiente de correlación de Spearman). Los promedios altos en todas las dimensiones del modelo SERVQUAL: tangibilidad (4.75), fiabilidad (4.74), capacidad de respuesta (4.60), seguridad (4.74) y empatía (4.54), indican una percepción general muy positiva. Estos resultados confirman que una buena calidad del servicio influye directamente en la experiencia satisfactoria del cliente en las cafeterías evaluadas.

Mgaya & Gwahula (2024), en su investigación denominada *The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction at St. Joseph Referral Hospital-Peramiho, Tanzania* (Peramiho, Tanzania), tuvieron como propósito determinar el impacto de la calidad del servicio sobre la percepción del cliente en el sector salud. Empleó un enfoque positivista, con un diseño transversal. El estudio utilizó un muestreo aleatorio simple para seleccionar a 123 encuestados, mientras que los datos se solicitaron a través de un cuestionario. Para el tratamiento estadístico, se aplicó el modelo de ecuaciones estructurales (SEM), para evaluar la relación entre las trayectorias estructurales. Los hallazgos mostraron una asociación positiva y sólida entre los componentes de la calidad del servicio y la percepción satisfactoria del paciente. Las correlaciones obtenidas fueron: tangibilidad (0.945), fiabilidad (0.954), capacidad de respuesta (0.947), seguridad (0.948) y empatía (0.937), todas por encima de 0.93. Estos resultados indican que, a mayor percepción de calidad en cada dimensión evaluada, mayor es el nivel de satisfacción del

paciente, evidenciando una correlación directa con significancia estadística entre los elementos analizados.

Wulansari, Suryanto, & Santi (2024) desarrollaron la investigación *The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction with the Intention to Choose a Hospital Again* (ciudad de Surabaya, provincia de Java Oriental, Indonesia), cuyo objetivo fue examinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del consumidor con la intención de volver a elegir un hospital. Los sujetos de esta investigación fueron 104 encuestados que habían utilizado los servicios del hospital. El enfoque del estudio fue cuantitativo y transversal. Se recopilaron datos de pacientes atendidos en cuatro hospitales. Los datos obtenidos demostraron que existe una relación favorable entre el desempeño del servicio y la conformidad del usuario. La investigación muestra en los resultados, que tanto la calidad del servicio como la satisfacción del cliente tienen un efecto positivo sobre la intención de reutilizar los servicios hospitalarios. En el modelo de regresión lineal múltiple, el coeficiente de regresión para la calidad del servicio fue 0.523 y para la satisfacción del cliente fue 0.078, mientras que el coeficiente de determinación (R^2) fue de 0.639, lo que indica que el 63.9 % de la variabilidad en la intención de reelección del hospital se explica por estas dos variables.

Anwarul et al. (2023) en su artículo científico titulado *Relationship between e-service quality dimensions and online banking customer satisfaction (Bangladés)*, tuvieron como objetivo principal determinar cómo se relacionan diversos aspectos de la calidad del servicio electrónico con la satisfacción de los clientes de banca en línea. Se recopiló información de tres bancos comerciales de Bangladesh mediante una encuesta en línea. El estudio fue cuantitativo y exploratorio. Se consideraron los clientes que utilizaban frecuentemente los servicios de banca en línea/por internet. El tamaño de la muestra fue de $n=200$ y se adoptó un muestreo no probabilístico.

La estimación basada en regresión demostró que todas las categorías de la prestación del servicio tienen un efecto positivo en la satisfacción del cliente que utiliza canales electrónicos financieros, siendo estadísticamente significativos con valores de p inferiores o cercanos a 0.05 y coeficientes β que oscilan entre 0.138 y 0.286. Además, el modelo explicó un 69.4% de la variabilidad total ($R^2 = 0.694$) en la satisfacción del cliente. Los resultados de este estudio demostraron que la calidad del servicio electrónico desempeñó un papel importante en la satisfacción del cliente de banca en línea.

Providence et al. (2022) en el artículo denominado *Hospital Service Quality and Patients' satisfaction within Soddo Christian Hospital PLC, Walaitta Region, Southwestern Ethiopiam (Walaita, Etiopía)*, tuvieron como propósito identificar los determinantes que impactan en el nivel de satisfacción del consumidor en Soddo Christian Hospital. Este estudio fue una investigación cuantitativa, transversal y de evaluación crítica. La investigación utilizó un enfoque fundamentado en SERVQUAL, orientado a medir el nivel de satisfacción del paciente con la atención brindada. Se recolectaron muestras utilizables de 250 cuestionarios de una población de 302, que se distribuyeron a los pacientes. Los resultados evidenciaron que todas las categorías de la calidad del servicio, de acuerdo con la estructura SERVQUAL, presentaron una correlación positiva y significativa con la satisfacción del paciente. Específicamente, la dimensión de capacidad de respuesta mostró la correlación más alta ($r=0.730$) y resultó ser el único factor con efecto predictivo significativo sobre la satisfacción ($p = 0.000$), mientras que las demás dimensiones: tangibilidad ($r = 0.635$), confiabilidad ($r = 0.645$), seguridad ($r = 0.620$) y empatía ($r = 0.622$), mostraron asociaciones moderadas, pero no predictivas en el análisis de regresión. Se concluyó que mejorar la capacidad de respuesta del personal es primordial para incrementar la satisfacción en el contexto hospitalario.

2.2 Marco conceptual

2.2.1 Calidad del Servicio

2.2.1.1 Teorías/Definiciones

La calidad del servicio es la capacidad de una organización para cumplir e incluso superar las expectativas de sus usuarios. Este logro se refleja en la fidelidad de los clientes y también en su disposición a recomendar el servicio, lo que contribuye a la sostenibilidad y al reconocimiento institucional. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de la atención se refiere al nivel en que los servicios de salud ofrecidos a una persona o comunidad logran los resultados esperados en salud y se basan en el conocimiento profesional respaldado por evidencia confiable (Moreno & Cazorla, 2023).

La calidad del servicio en salud se entiende como un componente esencial del bienestar y de la calidad de vida de las personas, vinculada al ejercicio del derecho a la salud y al desarrollo humano. Este concepto abarca la capacidad de los establecimientos para brindar una atención segura, efectiva, equitativa y respetuosa de la dignidad del usuario. Además, implica responder a las necesidades y expectativas de los pacientes mediante una gestión eficiente que promueva la mejora continua y fortalezca la confianza en los servicios sanitarios (MINSA, 2009).

Oliver (1997), planteó la Teoría de expectativas y percepciones, en la que los consumidores evalúan un producto o servicio en función de un marco de referencia que ya poseen antes de la experiencia. Esta conceptualización está compuesta por sus expectativas construidas a partir de múltiples fuentes: experiencias anteriores, sugerencias de terceros, mensajes de marketing e incluso creencias culturales. Al momento de utilizar o consumir un servicio, el individuo observa objetivamente lo que recibe y genera inmediatamente una percepción subjetiva, influenciada por su interpretación, emociones y entorno. Esta percepción puede coincidir o no con lo que esperaba, y es justamente en

la comparación donde se origina la valoración del servicio. Por tanto, esta teoría resalta que la calidad y la satisfacción son constructos relacionales, que dependen tanto de lo que se entrega como de lo que el usuario anticipaba.

Esta teoría refiere que los consumidores juzgan los servicios comparando lo que obtienen con lo que esperaban. Estas expectativas se forman por experiencias previas, recomendaciones, publicidad y aspectos culturales. La percepción del servicio también se ve afectada por el contexto y las emociones durante su uso. Al final, la satisfacción depende de cómo se relacionan las expectativas con la experiencia real.

La teoría de los Momentos de la Verdad, desarrollada por Jan Carlzon en 1987, menciona sobre la importancia crítica de cada interacción entre un cliente y una empresa. La teoría ha influido en diversas organizaciones, destacando que la calidad del servicio se construye en cada interacción y que el éxito empresarial depende de la capacidad de convertir cada momento de la verdad en una experiencia positiva para el cliente. Asimismo, promueve un enfoque descentralizado que empodera al personal de primera línea con capacidad para actuar con autonomía, rompiendo estructuras jerárquicas rígidas y agilizando la capacidad de respuesta. Así, estos momentos se configuran como el espacio donde la calidad del servicio se verifica o se pierde (Buhalis & Islam, 2022). La teoría de los Momentos de la Verdad resalta que cada encuentro entre el cliente y el servicio puede definir la imagen de una empresa. Este concepto enfatiza la importancia de cuidar cada interacción, debido a que es determinante en la percepción de la calidad.

La teoría de W. Edwards Deming (1950) propone un enfoque sistemático para mejorar la calidad en las organizaciones a través del ciclo PHVA, que significa Planear, Hacer, Verificar y Actuar, también llamado Ciclo de Deming. Se busca mejorar continuamente los procesos mediante una secuencia de pasos. Este modelo promueve que los estándares de calidad sean revisados continuamente y mejorados. En la fase de planificación, se

identifican necesidades y se diseñan procesos; luego se ejecuta lo proyectado, se controla el resultado con indicadores de calidad, y finalmente se actúa en función de los datos obtenidos para introducir mejoras. Además, Deming formuló principios fundamentales para transformar la cultura empresarial, como promover el liderazgo, eliminar el miedo, capacitar al personal, y priorizar la mejora continua. También advirtió sobre prácticas dañinas frecuentes en las empresas, como la falta de visión a largo plazo, la rotación constante de directivos, el exceso de enfoque en resultados inmediatos y la competencia interna que fragmenta los equipos (Swamidass, 2000).

La teoría del Dr. Joseph M. Juran (1988) se enfoca en la gestión de la calidad desde un enfoque más organizacional que estadístico. Define la calidad como la conformidad con el uso previsto y con las especificaciones establecidas. Su propuesta principal, conocida como la Trilogía de la Calidad, plantea tres procesos esenciales para alcanzar altos estándares: la planeación, el control y el mejoramiento. En la planeación, se diseña un sistema que cumpla con metas definidas bajo condiciones reales de operación. Luego, en el control de calidad, se supervisa que el sistema funcione eficazmente y se ajusten las desviaciones. Finalmente, el mejoramiento busca superar el rendimiento actual mediante innovaciones que eleven el nivel de desempeño. Juran considera que estos tres procesos son universales y deben ejecutarse en secuencia estructurada para lograr avances sostenibles en la calidad (Bernal Magaña, 2017).

2.2.1.2 Modelos-Dimensiones

Zeithaml et al. (1993), proponen el modelo SERVQUAL, que es una herramienta diseñada para evaluar cómo los usuarios valoran la calidad de los servicios que reciben. Parte de una comparación entre lo que el cliente espera y lo que realmente experimenta en el momento de utilizar un servicio. Esta diferencia revela aspectos que pueden generar satisfacción o, por el

contrario, decepción. Para hacer esta medición el modelo identifica cinco elementos clave que influyen en la percepción del cliente: la confiabilidad del servicio, la disposición del personal para atender, el nivel de seguridad que se transmite, la cercanía en el trato y la presentación física del entorno o de los elementos usados en la prestación.

El modelo SERVQUAL, evalúa la calidad del servicio a través de cinco dimensiones. Los elementos tangibles se refieren a la apariencia física del lugar, equipos y personal, lo cual influye en la primera impresión del cliente. La fiabilidad implica cumplir con lo prometido de manera constante y sin errores. La capacidad de respuesta se relaciona con la rapidez y disposición para atender solicitudes. La seguridad abarca el conocimiento, la cortesía y la confianza que transmite el personal. Por último, la empatía refleja el trato personalizado y la atención a las necesidades individuales del usuario (Paredes & Santos, 2022). Estas dimensiones permiten identificar brechas entre lo que el cliente espera y lo que realmente percibe, ayudando a mejorar la experiencia del servicio ofrecido. El enfoque integral del modelo facilita una evaluación completa, promoviendo acciones correctivas centradas en la satisfacción del cliente.

El Modelo de la Cadena de Servicio y Ganancias (*Service Profit Chain*) fue presentado por primera vez en el año 1994, por Heskett y colaboradores, plantea que la calidad del servicio es un componente fundamental para alcanzar resultados financieros sostenibles. En lugar de considerarla un valor aislado, el modelo la sitúa en el centro de una cadena causal que comienza con el entorno laboral interno. Las organizaciones que invierten en condiciones laborales positivas, formación continua y procesos eficientes logran que sus empleados brinden servicios de mayor calidad. Esta calidad se mide por la precisión o eficiencia, también por la calidez, consistencia y capacidad de resolver necesidades del cliente. Cuando el servicio entregado supera las expectativas o resuelve problemas con eficacia, se fortalece la percepción de valor en el usuario (Granados et al., 2022).

El Modelo de la Cadena de Servicio y Ganancias identifica siete dimensiones clave: calidad interna del servicio, satisfacción y lealtad del empleado, productividad, valor del servicio, satisfacción del cliente, lealtad del cliente y rentabilidad. Todas se conectan en una secuencia que inicia dentro de la organización y culmina en el éxito financiero, mostrando cómo el bienestar del personal impacta directamente en la experiencia del cliente y en los resultados de la empresa (Heskett et al., 1994).

El modelo de Grönroos plantea que la percepción de la calidad del servicio se construye a partir de tres dimensiones: calidad técnica, que se refiere al resultado tangible recibido por el cliente; calidad funcional, relacionada con la forma en que se presta el servicio, como el trato y el ambiente e imagen corporativa, que influye en cómo el cliente interpreta su experiencia. Estas dimensiones interactúan entre sí durante todo el proceso de atención y juntas determinan la evaluación que el usuario hace del servicio recibido. Esta concepción rompe con enfoques tradicionalmente centrados en estándares internos y destaca la importancia de la experiencia subjetiva del usuario (Torres & Vásquez, 2015).

El modelo subraya que, para lograr ventaja competitiva, las organizaciones deben gestionar los resultados técnicos, así como la interacción con el cliente y la reputación general percibida.

2.2.2 Satisfacción de los Pacientes

2.2.2.1 Teorías/Definiciones

La satisfacción del paciente es una evaluación positiva de la atención médica recibida en un centro de salud es un determinante esencial de la calidad de la prestación de servicios de salud. Es una evaluación subjetiva de las reacciones cognitivas y emocionales del paciente, resultante de la interacción entre sus expectativas y las percepciones de la atención recibida (Yeboah & Amponsah, 2025).

La satisfacción del usuario refleja el nivel con que una organización de salud logra responder a las expectativas y percepciones que los pacientes tienen sobre los servicios recibidos. Constituye un indicador esencial de la calidad de la atención, pues su cumplimiento incide directamente en las actitudes, decisiones y comportamientos de los usuarios frente al sistema de salud (MINSA, 2012).

Refleja cómo este valora la atención médica recibida, combinando tanto sus emociones como sus expectativas. Es esencial para entender si el servicio cumplió con lo que el usuario esperaba.

La Teoría de la Experiencia del Cliente, fue planteada por Schmitt (1999). Propone que las decisiones de compra y la fidelidad de los consumidores se basan de varios elementos: como las características funcionales de los productos o servicios, sensaciones. Emociones, pensamientos y vínculos que las personas desarrollan durante su interacción con una marca. El enfoque experiencial busca generar vivencias memorables a través de estímulos multisensoriales y conexiones emocionales. Schmitt plantea cinco tipos de experiencias: las sensoriales (lo que el cliente ve, oye o percibe físicamente), las emocionales (lo que siente), las cognitivas (cómo reflexiona o aprende), las conductuales (cómo actúa o cambia sus hábitos), y las sociales (cómo se relaciona con otros a través de la marca). Así, la experiencia se convierte en un valor agregado que puede marcar la diferencia frente a la competencia, influir en la marca y fortalecer el compromiso del cliente a largo plazo.

La teoría de la experiencia del cliente, propuesta por Pine y Gilmore (1999) en *The Experience Economy*, sostiene que las empresas además de competir por ofrecer productos y servicios también generan experiencias significativas. Según los autores, en esta nueva economía. Las experiencias deben ser diseñadas intencionalmente, para su posterior aplicación al usuario. Cada punto de contacto con el cliente representa una oportunidad para

impactar sensorial y emocionalmente, y así diferenciarse de la competencia. Pine y Gilmore plantean que, al igual que los bienes y servicios, las experiencias pueden ser comercializadas, y quienes las ofrecen deben pensar en su puesta en escena, en el guion y en la ambientación que envuelve al consumidor. Lo esencial está en hacer que el cliente reciba algo útil y que viva algo inolvidable. En este contexto, la autenticidad, la personalización y el valor simbólico cobran más relevancia que la simple funcionalidad del producto.

2.2.2.2 Modelos-Dimensiones

El modelo de Howard-Sheth (1969) explica cómo los consumidores toman decisiones de compra a partir de cuatro dimensiones: los estímulos del entorno, las variables perceptuales, las variables de aprendizaje y los resultados. Primero, los estímulos del entorno influyen en la atención del consumidor. Luego, las variables perceptuales filtran e interpretan esa información. A partir de ello, las variables de aprendizaje forman actitudes y hábitos que guían la decisión. Finalmente, el modelo considera los resultados, como la elección realizada y el nivel de satisfacción generado. Este enfoque permite comprender el proceso completo del comportamiento del consumidor. Proporciona un marco teórico integral para entender cómo los consumidores toman decisiones de compra y cómo se forma su satisfacción a partir de ese proceso. El modelo explica que el consumidor evalúa múltiples alternativas basándose en percepciones, actitudes previas, motivaciones, y la información disponible, y que la congruencia entre las expectativas formadas y la experiencia obtenida determina su grado de satisfacción. Cuando el desempeño del producto o servicio cumple o supera las expectativas del cliente, se genera satisfacción; en caso contrario, insatisfacción. Asimismo, el modelo subraya la importancia de las variables exógenas (como la influencia social y cultural) en la formación de expectativas (Gozmir et al., 2024).

Por tanto, para lograr una alta satisfacción, las empresas deben comprender el comportamiento racional del consumidor y los factores contextuales que condicionan su experiencia y decisión final.

El modelo de Kano, desarrollado por el profesor Noriaki Kano en 1984, constituye un enfoque estructurado para identificar y clasificar los atributos de productos y servicios en función de su impacto en la satisfacción del cliente. Este modelo se basa en la premisa de que no todos los atributos generan satisfacción o insatisfacción en igual medida, por lo que propone dimensiones diferenciadas que incluye cualidades imprescindibles, unidimensionales, atractivas, indiferentes, inversas y cuestionables. Las dimensiones imprescindibles son esenciales, cuya ausencia genera fuerte insatisfacción, aunque su presencia no incrementa proporcionalmente la satisfacción. Las unidimensionales producen satisfacción en proporción directa al nivel de cumplimiento, mientras que las atractivas, al ser inesperadas, generan deleite sin que su ausencia sea percibida negativamente. Las dimensiones indiferentes no afectan la percepción del cliente, y las inversas generan rechazo si se presentan. Este modelo ofrece a los gestores una herramienta para priorizar recursos en función del valor percibido por el cliente (Kermanshachi et al., 2022).

El modelo de satisfacción del cliente de Silberman et al. (2016) se centra en evaluar la percepción de los usuarios respecto a la atención en el primer nivel de salud. Propone seis dimensiones: trato del médico, condiciones físicas del establecimiento, atención del personal de salud, claridad en las explicaciones, elementos complementarios de atención, y dificultades para el acceso o permanencia.

El tratamiento médico, que abarca el conocimiento profesional y la mejora clínica; las instalaciones, valorando especialidades, farmacia y condiciones físicas del centro; la actitud del médico, enfocada en la amabilidad y calidad del trato; los elementos necesarios para la atención, como la

organización del servicio y la privacidad; las explicaciones recibidas, que se centran en la comprensión del diagnóstico y el tratamiento; y las dificultades para obtener atención, que consideran la escasez de personal, problemas de acceso y complicaciones para conseguir citas.

El modelo de Silberman representa un enfoque valioso al integrar tanto dimensiones clínicas como aspectos organizativos y humanos en la evaluación de la satisfacción del paciente. Sin embargo, una posible limitación es que prioriza variables estructurales del sistema de salud sin profundizar en factores culturales o emocionales que también condicionan la percepción del usuario.

Además, al centrarse en el primer nivel de atención, no necesariamente refleja la experiencia del paciente en niveles más complejos o especializados. Pese a ello, su estructura permite detectar áreas críticas como la accesibilidad o la comunicación médico-paciente, fundamentales para mejorar la atención desde una perspectiva centrada en el usuario.

2.3 Glosario de términos

- **Acceso al servicio de salud.** Se refiere a la posibilidad real que tienen las personas para llegar y utilizar los servicios de salud cuando los necesitan, permitiendo que todos, reciban atención oportuna.
- **Atención centrada en el usuario.** Es un enfoque que pone al paciente en el centro de todas las decisiones y acciones del servicio de salud. Esta forma de atención promueve el respeto, la autonomía y el acompañamiento continuo.
- **Calidad del servicio.** Se entiende como la percepción que tienen los usuarios respecto a la atención en un establecimiento de salud. Que el servicio cumpla con lo prometido al paciente, considerando aspectos como puntualidad, empatía del personal y condiciones del ambiente.
- **Capacidad de respuesta.** Describe la disposición y rapidez con la que el personal atiende las necesidades de los usuarios. Una alta

capacidad de respuesta mejora la experiencia del paciente, al sentir que es importante y que su tiempo vale.

- **Elementos tangibles.** Son los aspectos físicos y visibles del servicio, como el mobiliario, los equipos médicos, el estado del local y la presentación del personal.
- **Establecimiento de Salud.** es una unidad operativa destinada a promover, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar la salud de las personas. Cuenta con recursos humanos, infraestructura y equipos adecuados, organizados por niveles de atención y categorías que definen su capacidad resolutive y garantizan una atención integral y continua (MINSA, 2011; MINSA, 2016).
- **Experiencia del paciente.** Es el conjunto de vivencias, emociones y juicios que un usuario tiene desde que entra al centro hasta que se retira. Involucra la atención médica, el trato del personal, los tiempos de espera y la información recibida.
- **Gestión en salud.** Es el conjunto de acciones que buscan organizar y mejorar los servicios de atención de salud. Incluye la planificación, uso eficiente de recursos, coordinación del personal y evaluación continua.
- **Indicadores de calidad.** Son medidas específicas que permiten evaluar si un establecimiento está brindando un servicio adecuado y seguro. Son herramientas útiles para tomar decisiones, mejorar procesos y garantizar que los servicios funcionen de forma eficiente.
- **Mejoramiento continuo de la calidad.** Es un proceso progresivo que compromete a toda la organización en la búsqueda de la excelencia. Utiliza herramientas para fortalecer la competitividad, promoviendo una cultura orientada a la mejora constante y la calidad del servicio (MINSA, 2023).
- **Percepción del usuario.** Es la forma en que cada paciente interpreta y valora el servicio recibido. Esta percepción depende de hechos

objetivos, así como de las emociones, expectativas previas y experiencias pasadas.

- **Sistema de gestión de la calidad.** Comprende procesos que orientan y evalúan el desempeño de los establecimientos sanitarios públicos y privados, garantizando una atención eficiente y una gestión basada en la mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad (MINSA, 2012).

2.4 Formulación de la hipótesis

2.4.1 Hipótesis general

H1: Existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

2.4.2 Hipótesis específicas

Hipótesis específica 1

H1: Existe una relación significativa entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

Hipótesis específica 2

H1: Existe una relación significativa entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

Hipótesis específica 3

H1: Existe una relación significativa entre la capacidad de respuesta del personal médico-administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre la capacidad de respuesta del personal médico y administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

Hipótesis específica 4

H1: Existe una relación significativa entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

Hipótesis específica 5

H1: Existe una relación significativa entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

H0: No existe una relación significativa entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Aspectos metodológicos

3.1.1 Tipo y Diseño de investigación

Esta investigación corresponde al tipo aplicada, según Grove et al. (2016), también se denomina investigación práctica, en cuanto se lleva a cabo con el propósito de generar conocimientos que contribuyan directamente a mejorar la atención clínica. Su función principal es brindar soluciones concretas a problemas reales, facilitar la toma de decisiones informadas y permitir anticipar o manejar los resultados que surgen en contextos prácticos del día a día.

Según Córdova (2019) este estudio tiene un enfoque cuantitativo porque tiene como objetivo evaluar y obtener datos precisos sobre las variables del estudio, utilizando herramientas que han sido comprobadas como seguras y exactas para garantizar resultados confiables y de esa forma determinar el comportamiento de estas. El uso del método científico y de técnicas propias de cada ciencia se realiza de manera estricta, pues se considera que es la única manera confiable de llegar a conocer la verdad o de encontrar nuevos saberes dentro del campo científico (Ñaupas et al. 2014).

Esta investigación se considera de tipo transversal. Pino (2024) refiere que estos estudios consisten en recolectar información con el propósito de describir las variables y analizar su comportamiento en un mismo tiempo. En este sentido, Manterola et al., 2023 establece que, desde el punto de vista del tiempo y el lugar, estos estudios se consideran observacionales, debido a que la información se recoge en un solo momento específico. Por ello, todas las mediciones se hacen una sola vez y no se realiza ningún seguimiento posterior.

El método de estudio correlacional, que de acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular (Ortiz et al., 2019), fue adoptado en debido a que se busca identificar el grado de relación entre dos o más variables sin manipularlas, según Shaughnessy et al. (2007), una correlación se da cuando dos mediciones diferentes de la misma persona, evento, o cosa varían simultáneamente, esto es, cuando las puntuaciones de una variable covarían con las puntuaciones de la otra variable.

Finalmente, se establece que esta investigación es de carácter no experimental, puesto que no se interviene directamente sobre las variables, sino que se analizan tal como ocurren en su escenario natural. Además, se caracteriza por tener un control más limitado sobre las variables. Sin embargo, su gran ventaja radica en que permite observar los fenómenos tal como ocurren en su entorno habitual, con una visión más auténtica y representativa de la realidad cotidiana.

3.1.2 Identificación de variables

Variable Calidad del Servicio

La calidad del servicio es la medida en que un servicio logra cumplir o superar las expectativas que tienen los usuarios. Es la percepción de la persona atendida respecto a la utilidad, oportunidad y trato recibido durante el servicio. Implica aspectos como la amabilidad del personal, la claridad en la información brindada, la atención a las necesidades individuales y la experiencia general durante el proceso.

La variable calidad del servicio se estructura a partir de las siguientes dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.

Variable Satisfacción del Paciente

La satisfacción del paciente es el nivel de conformidad que una persona siente con respecto a la atención recibida en un servicio de salud. Es un indicador fundamental para valorar la experiencia del usuario y conocer si sus expectativas fueron cumplidas. Además, refleja el grado de confianza y bienestar que el paciente desarrolla durante su proceso de atención.

De acuerdo con Silberman et al. (2016), las dimensiones son tratamiento médico, instalaciones, actitud del médico, elementos necesarios para la atención de la enfermedad, explicaciones recibidas y dificultades para obtener atención.

3.1.3 Operacionalización de variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicador	N° de pregunta
Calidad del Servicio	La calidad del servicio es la capacidad de una organización para cumplir e incluso superar las expectativas de sus usuarios. Este logro se refleja en la fidelidad de los clientes y también en su disposición a recomendar el servicio (Moreno & Cazorla, 2023)	La calidad del servicio es la medida en que un servicio logra cumplir o superar las expectativas que tienen los usuarios. Es la percepción de la persona atendida respecto a la utilidad, oportunidad y trato recibido durante el servicio	Elemento tangible	Equipamiento	1
				Espacio físico	2
				Apariencia	3
				Materiales	4
			Fiabilidad	Cumplimiento	5
				Resolución	6
				Ejecución	7
				Interés	8
				Errores	9
			Capacidad de respuesta	Ayuda	10
				Agilidad	11
				Colaboración	12
				Respuesta	13
			Seguridad	Seguridad	14
				Confianza	15
				Cortesía	16
				Capacitación	17
			Empatía	Atención	18
				Flexibilidad	19
				Personalización	20
				Cuidado	21
				Requerimientos	22
			Tratamiento médico	Conocimientos	23
				Mejoría clínica	24
				Buen trato	25
				Buena atención	26

Satisfacción del paciente	La satisfacción del paciente es una evaluación subjetiva de las reacciones cognitivas y emocionales del paciente, resultante de la interacción entre sus expectativas y las percepciones de la atención recibida (Yeboah & Amponsah, 2025)	La satisfacción del paciente es el nivel de conformidad que una persona siente con respecto a la atención recibida en un servicio de salud. Es un indicador fundamental para valorar la experiencia del usuario y conocer si sus expectativas fueron cumplidas		Buena revisión	27
				Explicación	28
			Instalaciones	Especialidades	29
				Laboratorio	30
				Baños	31
				Farmacia	32
				Insumos básicos	33
			Médico	Amable	34
				Saludo	35
				Dedicación	36
				Calidez	37
				Escucha	38
				Explique	39
			Elementos de atención	Organización	40
				Privacidad	41
				Canalización	42
			Explicaciones	Origen	43
				Cuidados	44
				Consecuencias	45
				Medicinas	46
			Dificultades	Expediente	47
				Distancia	48
				Horarios	49
				Falta médico	50
				Citas	51

3.2 Población y muestra

El tamaño de la muestra se calculará mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas, mientras que el procedimiento de selección de los participantes corresponderá a un diseño muestral por conveniencia, dado que se considerará a los pacientes que acudirán al servicio de consulta externa y accedan voluntariamente a participar durante el periodo de recolección. Asimismo, Shaughnessy (2007) establece que el muestreo por conveniencia o propositivo implica seleccionar a los encuestados principalmente en la base de sus disponibilidad y voluntad para responder las encuestas.

Este diseño es frecuente en estudios aplicados en salud, donde no existe un registro nominal completo que permita realizar un muestreo aleatorio. Por tanto, el uso de la fórmula permitirá determinar una cantidad suficiente de participantes para lograr un nivel aceptable de precisión en los resultados, mientras que el enfoque por conveniencia facilitará la viabilidad operativa del trabajo de campo y el acceso directo a la población objetivo. Es decir, el diseño muestral por conveniencia permitirá reunir información representativa de la realidad del servicio sin requerir un proceso aleatorio, priorizando la accesibilidad, el tiempo y los recursos disponibles.

De esta manera, el cálculo estadístico cumplirá una función de estimación cuantitativa del tamaño de la muestra, y el tipo de muestreo expresará la estrategia práctica y contextual de selección, integrándose ambos en un diseño descriptivo de carácter cuantitativo que equilibrará rigor metodológico y factibilidad en la ejecución del estudio. El tamaño de la muestra correspondiente al Centro de Salud Breña (I-3) se estimará considerando una población mensual aproximada de 3 797 pacientes (Ministerio de Salud del Perú, 2025). Se establecerá un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$). El grado de seguridad estadística con que se interpretarán los resultados; un 95 % indica que, si el estudio se repitiera muchas veces, el valor real de la población estaría dentro del intervalo calculado la mayoría de las veces (Vera et al., 2025), una proporción esperada de $p = 0.5$ y $q = 0.5$, y un

margen de error del 5 %, obteniéndose una muestra de 350 pacientes. La selección se realizará mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo a usuarios de consulta externa que aceptarán participar voluntariamente durante el periodo de cuatro semanas correspondiente a la recolección de datos

fórmula base:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2 (N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$n = \frac{3797(1.96)^2 (0.5) (0.5)}{(0.05)^2 (3797 - 1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)} \cong 350$$

Valores para poblaciones finitas

Con:

N = 3 797

Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%)

P = 0.5, q = 0.5

E = 0.05 (margen de error del 5%)

Criterios de inclusión

Los usuarios externos que serán encuestados comprenden a personas de ambos sexos, mayores de 18 años,

Usuario externo que otorgue su aprobación para participar en la encuesta.

Criterios de exclusión

Los usuarios externos menores de 18 años,

Usuario externo que no otorgue su aprobación para participar en la encuesta.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1 Técnicas: Encuesta

La encuesta es un método propio de los estudios cuantitativos que se utiliza para recopilar información general. Para ello, se emplea un cuestionario con preguntas previamente definidas, que se aplica a un grupo de personas

seleccionadas como muestra representativa de una población más amplia (Feria et al., 2020).

3.3.2 Instrumentos: Cuestionario

El cuestionario es un instrumento para recoger información que llena el encuestado. Consiste en una serie de preguntas ordenadas y agrupadas por indicador o variable y el motivo del estudio (Balderas, 2015)

Para evaluar la variable “Calidad de servicio” y “Satisfacción del paciente”, se aplicará un instrumento adaptado del “Formulario del servicio percibido por los asegurados en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”, elaborado por Zeithaml, Parasuraman & Berry, en 1993. Este cuestionario comprende un total de 22 preguntas distribuidas en cinco dimensiones esenciales: aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Para la medición de la variable “Satisfacción del paciente”, se empleará ítems del “Cuestionario sobre la satisfacción de los usuarios del primer nivel de atención”, diseñado por Silberman y colaboradores en el año 2016, en su versión adaptada. Con ítems organizados en dimensiones: atención médica, condiciones de la infraestructura, desempeño del profesional, componentes del servicio, claridad en la información brindada y posibles inconvenientes durante la atención. La escala utilizada será de tipo Likert con cinco opciones de respuesta.

3.4 Procesamiento de la información.

Cada respuesta obtenida a través del cuestionario estructurado y de la ficha de recolección de datos será codificada numéricamente para su procesamiento. Los datos se registrarán y organizarán en una hoja de cálculo elaborada en Microsoft Excel, versión 2019, asegurando la limpieza, coherencia y validación previa a su análisis. Posteriormente, la información será procesada con el programa estadístico SPSS versión 27.0 o superior para Windows (IBM,

EE. UU.), el cual permite realizar tanto análisis descriptivos como inferenciales de las variables consideradas en el estudio.

En una primera fase, se efectuará un análisis estadístico descriptivo que permitirá caracterizar la muestra e identificar tendencias generales en las dimensiones de estudio, calidad del servicio y satisfacción del paciente. Los resultados se presentarán en tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras y diagramas circulares, con el fin de facilitar la interpretación visual de los hallazgos.

Para evaluar la consistencia interna del instrumento de medición, se calculará el coeficiente alfa de Cronbach (α), cuyo valor igual o superior a 0.70 se considerará indicativo de una fiabilidad aceptable del cuestionario aplicado.

En una segunda fase, se desarrollará un análisis estadístico inferencial, con el propósito de contrastar las hipótesis de investigación y determinar la relación entre las variables. Dado que las variables son de tipo ordinal y cuantitativo, se empleará el coeficiente de correlación de Pearson (r) para establecer el grado de asociación entre la calidad del servicio percibida y la satisfacción de los pacientes, considerando un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$.

Asimismo, se aplicarán pruebas de normalidad de los datos (Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk) y, en caso de no cumplirse los supuestos de normalidad, se podrá utilizar una alternativa no paramétrica, como el coeficiente de Spearman (ρ). Estos procedimientos permitirán sustentar con rigor empírico las conclusiones del estudio, garantizando la objetividad del análisis y la validez de las inferencias realizadas.

En la fase final, los resultados obtenidos se interpretarán de manera crítica y comparativa, con el marco teórico y estudios previos sobre calidad del servicio

en establecimientos de salud pública. Este abordaje metodológico integral asegura la credibilidad y coherencia del estudio realizado en el Centro de Salud de Breña.

3.5 Aspectos éticos

El desarrollo del proyecto seguirá criterios éticos reconocidos internacionalmente, como los principios de respeto, equidad y protección del participante humano, conforme lo establece la Declaración de Helsinki, que orientan la conducta ética de la investigación en cuanto a autonomía, justicia y responsabilidad hacia los involucrados.

Antes de aplicar los instrumentos, se informará a los pacientes sobre los objetivos y alcances del estudio. A quienes acepten participar, se les entregará un consentimiento informado voluntario. Se garantizará la confidencialidad de las respuestas y el uso exclusivo de los datos con fines investigativos.

CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de ejecución

ACTIVIDADES		2025																															
		ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOST			SEPTIEMB.				OCTUBRE				NOVIEMBR				DIC
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Búsqueda de información		X	X																														
Capítulo II	Antecedentes Nacionales e Internacionales		X	X	X	X																											
	Marco Teórico			X	X	X																											
	Glosario de Términos				X	X												X															
	Definición de los Instrumentos					X	X	X																									
Capítulo I	Realidad Problemática					X	X	X																									
	Problema General y Específicos						X	X	X																								
	Objetivo General y Específicos							X	X																								
	Justificación/ Importancia							X	X	X																							
	Limitación /								X	X																							

[illegible]

4.1. Presupuesto

Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
Internet	Consumo mensual	S/. 200.00	S/. 200.00
Transporte	Pasajes	S/. 20. 00 diarios	S/. 800.00
Copias	1 millar	S/. 0.20 por hoja	S/. 500.00
Útiles de Oficina	Varios	S/. 250.00	S/. 250.00
Consultorías de Estadística	Remuneración Estadista	S/. 1500.00	S/. 1500.00
Otros		S/. 200.00	S/. 200.00
		Total	S/. 3450

FUENTES DE INFORMACIÓN

Referencias Bibliográficas

- Anwarul, K., Islam, S., Mobarak, M., Shariful, M., & Sultana, T. (2023). Relationship between e-service quality dimensions and online banking customer satisfaction. *Banks and bank systems*, 18(1), 174–183. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(1\).2023.15](https://doi.org/10.21511/bbs.18(1).2023.15)
- Arce, M. A., & Aliaga (2023). Calidad de atención y satisfacción del usuario en un servicio de emergencia de un hospital del Seguro Social. *Acta Médica Peruana*, 40(4), 308–313. <https://doi.org/10.35663/amp.2023.404.2722>
- Balderas, M. (2015). *Administración de los servicios de enfermería* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Bernal, J. (2017). *Principios básicos de administración*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
- Carlzon, J. (1987). *El momento de la verdad*. Editorial Grijalbo. https://books.google.com.pe/books?id=jsEEQ605ijsC&pg=PA5&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false
- Buhalis, D., & Islam, M. S. (2022). Moment of truth. En *Encyclopedia of tourism management and marketing* (pp. 240–244). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800377486.moment.of.truth>
- Calle, M. F. (2023). Percepción de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la calidad de la atención médica que reciben en la etapa de media seguridad del Centro de Privación de Libertad - Cotopaxi N° 1. *FACSALUD-UNEMI*, 7(12), 93–102. <https://doi.org/10.29076/issn.2602-8360vol7iss12.2023pp93-102p>
- Calle, S. E. (2023). Diseños de investigación cualitativa y cuantitativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 1865–1879. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7016
- Chávez, Y. E. A., & Bueno, R. O. A. (2024). Assessing public service quality and user satisfaction: A case study of the district municipality of San

- Luis, Peru. *Nanotechnology perceptions*.
<https://doi.org/10.62441/nano-ntp.vi.1007>
- Córdova, A. M., Aparicio, M. I., y Huamanchumo, H. I. (2024). Calidad de servicio en un hospital del nivel II para la satisfacción del paciente en el Perú. *Revista científica en ciencias sociales*, 6, e601123. [10.53732/rccsociales/e601123](https://doi.org/10.53732/rccsociales/e601123)
- Córdova, I. (2019). *El proyecto de investigación cuantitativa: Con Minitab, SPSS y Excel* (6ª ed.). Editorial San Marcos E.I.R. Ltda.
- Dávila, D. F., & Chirinos, C. A. (2022). Quality of care in the EsSalud emergency service, northern Region, Peru. *Journal of Medicine and Life*, 15(12), 1563–1568. <https://doi.org/10.25122/jml-2021-0254>
- Espinoza, J. A. (2022). Sistema de indicadores de gestión docente para la educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 4089-4099. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2919
- Febres, R. J., & Mercado, M. R. (2020). Patient satisfaction and quality of care of the internal medicine service of Hospital Daniel Alcides Carrión. Huancayo - Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 20(3), 397–403. <https://doi.org/10.25176/rfmh.v20i3.3123>
- Gozmir, H., Makhrouf, S., & Chouhbi, A. (2024). Fundamental models of consumer purchasing behavior: An in-depth analysis since the 1960s. *Revista Multidisciplinar*, 6(2), e202419. <https://doi.org/10.23882/emss.24185>
- Granados, J. C., Pedraza, J. A., Pérez, L. M. & Gallarza, M. G. (2022). Las condiciones explicativas de la lealtad del cliente en las relaciones comerciales B2B. *Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 32(85), 49–66.
- Grove, S. K., Gray, J. R., & Burns, N. (2016). *Investigación en enfermería: Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia* (6.ª ed.). Elsevier.
- Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting the service-profit chain to work. *Harvard Business*

- Review*, 72(2), 164–174. <https://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work>
- Kermanshachi, S., Nipa, T. J., & Nadiri, H. (2022). Service quality assessment and enhancement using Kano model. *PLOS ONE*, 17(2), e0264423. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264423>
- Manterola, C., Hernández-Leal, M. J., Otzen, T., Espinosa, M. E., & Grande, L. (2023). Estudios de corte transversal. Un diseño de investigación a considerar en ciencias morfológicas. *International Journal of Morphology*, 41(1), 146–155. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022023000100146>
- Feria, H., Matilla, M., & Mantecón, S. (2020). *La entrevista y la encuesta: ¿métodos o técnicas de indagación empírica?* Revista Didasc@lia: D&E, (62). Publicación del CEPUT, Las Tunas, Cuba. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7692391>
- Mgaya, T. W., & Gwahula, R. (2024). The effect of service quality on customer satisfaction at St. Joseph referral hospital-Peramiho, Tanzania. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(2), 223–233. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2\(2\).19](https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(2).19)
- Ministerio de Salud del Perú. (2025). *Repositorio Único Nacional de Información en Salud – REUNIS*. <https://www.minsa.gob.pe/reunis/?op=3&niv=6&tbl=2>
- Ministerio de Salud. (2023). *Norma Técnica de Salud N.º 201-MINSA/DGIESP-2023: Estándares de calidad para evaluar establecimientos de salud que brindan servicios de cuidado integral de salud para adolescentes* (R.M. N.º 356-2023/MINSA). Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4100799/RM_356-2023-MINSA.pdf
- Ministerio de Salud. (2016). *Norma Técnica de Salud N.º 029-MINSA/DIGEPRES-V.02: Auditoría de la calidad de la atención en salud* (R.M. N.º 502-2016/MINSA). Dirección General de Gestión del

- Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/284837/NTS_Auditoria_Calidad_Atencion_2016.pdf
- Ministerio de Salud. (2012). *Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo* (R.M. N.º 527-2011/MINSA). Dirección General de Salud de las Personas, Dirección de Calidad en Salud.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390841/Gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica_para_la_evaluaci%C3%B3n_de_la_satisfacci%C3%B3n_del_usuario_externo_en_los_establecimientos_de_salud_y_servicios_m%C3%A9dicos_de_apoyo.pdf
- Ministerio de Salud. (2011). *Norma Técnica de Salud N.º 021-MINSA/DGSP-V.03: Categorías de establecimientos del sector salud*. Dirección General de Salud de las Personas.
<https://repositorio.minsa.gob.pe/handle/20.500.14196/334>
- Ministerio de Salud. (2009). *Política nacional de calidad en salud* (Documento técnico, R.M. N.º 727-2009/MINSA). Dirección General de Salud de las Personas, Dirección de Calidad en Salud.
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1362.pdf>
- Moreno Gavilanes, K. A., & Cazorla Basantes, G. (2023). Calidad del servicio de salud: un antecedente de la satisfacción del paciente de Riohospital de la ciudad de Riobamba (Ecuador). *Revista de Economía del Caribe*, (31), 1–27. Universidad del Norte.
<http://portal.amelica.org/ameli/journal/318/3184182007/>
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (4.ª ed., Bogotá: Ediciones de la U).
- Oliver, R. L. (1997). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*. McGraw-Hill.
http://file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/satisfaction-a-behavioral-perspective-on-the-consumer_compress.pdf

- Ortiz, L., Ortiz, L. E., Coronell, R. D., Hamburger, K., & Orozco, E. (2019). Incidencia del clima organizacional en la productividad laboral en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): un estudio correlacional. *Revista Latinoamericana de Hipertensión*, 14(2), 187–197. Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170263775012>
- Paredes, P. R., & Santos, E. D. (2022). Calidad del servicio y satisfacción en hospitales del sistema de seguridad social. *RAC: Revista Angolana de Ciências*, 4(1), e040110. <https://doi.org/10.54580/R0401.10>
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. *Harvard Business Press*. https://books.google.com.pe/books?id=5hs-tyRrSXMC&pg=PR7&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false
- Pino, R. (2024). *Metodología de la investigación: Elaboración de diseños para contrastar hipótesis* (3.^a ed.). Editorial San Marcos E.I.R.L.
- Providence, S., Cissy, K., & Sylvestre, M. (2022). Hospital service quality and patients' satisfaction within Soddo Christian Hospital PLC, walaitta region, southwestern Ethiopia. *KIBOGORA POLYTECHNIC SCIENTIFIC JOURNAL*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.33618/kpscj.2022.01.03>
- Razeena, M., Shareena, P., & Irfana, S. (2025). Through the lens of care: How healthcare professionals' perceptions of service quality influence patient satisfaction. *UCJC Business and Society Review*, 22(1), 60–85. <https://doi.org/10.3232/UBR.2025.V22.N1.02>
- Romero, R., Ochoa, F. A., Mori, G., Vilca, V. A., Gómez, F. Y., Carpio, F. del, Zárate, J. S., & Espinoza, R. J. (2023). Service quality and institutional image as predictors of customer satisfaction in municipalities of Perú. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(5), e885. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.885>

- Schmitt, B. H. (1999). *Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate*. Free Press.
https://www.academia.edu/33295895/Experiential_Marketing_Schmitt.
- Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2007). *Métodos de investigación en psicología* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Silberman, M. S., Moreno, L., Hernández, D., Martínez, A., & Ochoa, H. (2016). Construcción y validación de un instrumento para medir la satisfacción de los pacientes del primer nivel de atención médica en la Ciudad de México. *Gaceta Médica de México*, 152, 43-50.
[https://doi.org/10.1016/j.gmmed.2015.02.001:contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://doi.org/10.1016/j.gmmed.2015.02.001:contentReference[oaicite:0]{index=0}).
- Silva, R., Julca, F., Luján, P. E., y Trelles, L. R. (2021). Calidad del servicio y su relación con la satisfacción del cliente: Empresas turísticas de Canchaque-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII (Número Especial 3), 193-203.
- Swamidass, P. M. (Ed.). (2000). The Deming Cycle (Plan–Do–Check–Act). In *Encyclopedia of Production and Manufacturing Management*. Springer.
https://doi.org/10.1007/1-4020-0612-8_229
- Torres, M., & Vásquez, C. L. (2015). Modelos de evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis. *Compendium*, 18(35), 57–76.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88043199005>
- Vera, V. J., Zuzunaga, F. E., Huaman, C. H., Sanchez, N. M., y Gutierrez de Carrillo, C. I. (2025). Cálculo de tamaño muestral y precisión para estudios epidemiológicos: desarrollo e implementación del paquete CalculadoraPrevalencia en R. *Revista Peruana de Ciencia de la Salud*, 7(2). <https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.2.4>
- Villanueva, A., Tayco, R., & Estrope, C. (2025). Service quality and customer satisfaction among coffee shops in Dumaguete City, Philippines. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(4).
<https://doi.org/10.69569/jip.2025.064>

- Wulansari, O. D., Suryanto, & Santi, D. E. (2024). The relationship between service quality and customer satisfaction with the intention to choose a hospital again. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 5(2), 648–663. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.05.02.25>
- Yeboah, J. G., & Amponsah, K. T. (2025). The mediating role of service innovation in the relationship between customer orientation and patient satisfaction. *BMC Health Services Research*, 25, 803. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12794-7>
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1993). *Calidad total en la gestión de servicios: Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores*. McGraw-Hill. https://www.academia.edu/123369581/Calidad_total_en_la_gesti%C3%B3n_de_servicios#loswp-work-container

ANEXOS

ANEXO N° 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General		
¿Qué relación existe entre la calidad del servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación que existe entre la calidad del servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Variable 1 Calidad de Servicio Dimensiones • Elementos tangibles • Fiabilidad • Capacidad de respuesta • Seguridad • Empatía Variable 2 Satisfacción del paciente Dimensiones • Tratamiento Médico • Instalaciones: • Actitud del Médico • Elementos Necesarios para la Atención de la Enfermedad • Explicaciones Recibidas • Dificultades para Obtener Atención	<u>Tipo de Investigación</u> Aplicada <u>Enfoque</u> Cuantitativo <u>Diseño de Investigación</u> Transversal, correlacional, no experimental y descriptiva <u>Población y muestra</u> Población: 3 797 Muestra: 350 Método muestral: muestreo por conveniencia <u>Instrumentos de investigación</u> Encuesta Cuestionario <u>Procesamiento de la información</u> Cada respuesta obtenida mediante el cuestionario estructurado será codificada y organizada en Microsoft Excel (2019) para su validación, y luego procesada en SPSS versión 27.0 para realizar análisis descriptivos e inferenciales. Se aplicará el alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del instrumento y los coeficientes de Pearson o Spearman para determinar la relación entre calidad del servicio y satisfacción del paciente, con un nivel de significancia de $p < 0.05$. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos, interpretándose críticamente según el marco teórico y bajo criterios éticos.
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas		
¿Cuál es la relación entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre los elementos tangibles del servicio de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.		
¿Cuál es la relación entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre la fiabilidad en la prestación de servicios médicos y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.		
¿Cuál es la relación entre la capacidad de respuesta del personal médico y administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del personal médico y administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre la capacidad de respuesta del personal médico y administrativo y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.		
¿Cuál es la relación entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre las percepciones de seguridad de los pacientes sobre la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.		
¿Cuál es la relación entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana?	Determinar la relación entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.	Existe una relación significativa entre la empatía demostrada por el personal de salud y la satisfacción de los pacientes en un Centro de Salud de Lima Metropolitana.		

ANEXO N° 2 INSTRUMENTO
CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN
UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2025

N°	ÍTEMS	ESCALA				
		Nada de acuerdo	Algo de acuerdo	Bastante de acuerdo	Muy de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	El equipamiento en el Centro de Salud es moderno					
2	El Centro de Salud cuenta con buenas instalaciones					
3	El personal de salud del Centro se presenta limpio					
4	El servicio se brinda con materiales de calidad					
5	Cumplen con lo que ofrecen en la atención					
6	Dan importancia a resolver su problema de Salud					
7	Los servicios se realizan de manera adecuada					
8	El personal de salud muestra interés en resolver su problema					
9	Encuentra errores en la atención recibida					
10	El personal de salud está dispuesto a ayudarlo					
11	Lo atienden con rapidez					
12	El personal de salud muestra una actitud de apoyo					
13	Recibe una respuesta rápida y efectiva del personal de salud					
14	El personal de salud le transmite seguridad					
15	Se siente en confianza durante la atención					
16	El personal es amable con usted durante la atención					
17	La atención en el Centro de Salud es con personal capacitado					
18	Recibe una atención personalizada como paciente					
19	El Centro de Salud ofrece horarios flexibles para la atención					
20	Recibe un trato amable durante la atención					
21	La jefatura se preocupa por el bienestar de los pacientes					
22	La gestión del Centro sabe lo que necesitan los pacientes					
23	Los médicos saben cómo tratar su enfermedad					
24	El tratamiento que recibe le ayuda a mejorar su salud					
25	Valora el buen trato que recibe de todos los profesionales					
26	Considera que la atención recibida en general es muy buena					
27	Siente que los médicos hacen una atención clínica completa					
28	Los médicos le explican claramente sobre su enfermedad					
29	El Centro cuenta con las especialidades que usted necesita					
30	El laboratorio del Centro cuenta con todas las pruebas					
31	Los baños son suficientes para el uso de los pacientes					
32	La farmacia tiene las medicinas que usted necesita					
33	Cuenta con equipos y materiales para atender su problema					
34	Los médicos lo tratan con amabilidad					

35	Los médicos lo reciben siempre con un saludo cordial					
36	Los médicos dedican el tiempo necesario a su consulta					
37	Los médicos que lo atienden transmiten calidez en su trato					
38	Al decir sus problemas con el médico se siento escuchado					
39	El médico responde con claridad sus dudas					
40	El Centro de Salud está bien organizado					
41	Los consultorios permiten la privacidad en su consulta					
42	Se resuelve su referencia o transferencia si es necesario					
43	El médico le explica claramente las causas de su enfermedad					
44	Le explican los cuidados para controlar su enfermedad					
45	El médico explica las consecuencias de su enfermedad					
46	Desde el inicio le explican bien cómo tomar sus medicinas					
47	Considera que el área de Historias Clínicas necesita mejorar					
48	El Centro de Salud queda en un lugar de difícil llegada					
49	Le dificulta recibir atención en el horario de atención					
50	Es una constante las ausencias de los médicos que atienden					
51	Se debe mejorar el sistema para conseguir cita					

Nota. Adaptado de Paredes & Santos, 2022; Silberman, Moreno, Hernández, Martínez, & Ochoa (2016).

ANEXO N° 3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO/EXPERTOS

FICHA PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTO)

I.- DATOS GENERALES:

Nombres y Apellidos del Experto: **DR. GLENN ALBERTO LOZANO ZANELLY**

Nombre del instrumento de evaluación: **CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2025**

Autora del Instrumento: **KATHERINE SUSAN RUFASO GOCHE**

Título de la Investigación: **"LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA - LIMA 2025"**

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	CRITERIOS	Puntaje				
		1	2	3	4	5
1	CLARIDAD: El instrumento esta formulado con lenguaje apropiado.					X
2	OBJETIVIDAD: El instrumento propuesto permitirá alcanzar el objetivo planteado en el estudio.					X
3	ACTUALIDAD: El instrumento propuesto es adecuado al avance de la ciencia y tecnología.				X	
4	PROPÓSITO: Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.					X
5	SUFICIENCIA: Los ítems del instrumento comprenden los aspectos de cantidad y calidad.					X
6	ORGANIZACIÓN: El instrumento tiene una organización lógica y secuencial.					X
7	CONSISTENCIA: El instrumento comprende aspectos que son investigables.					X
8	COHERENCIA: El instrumento es adecuado para valorar el objeto de investigación.					X
9	INTENCIONALIDAD: El instrumento permitirá dar respuesta al problema de investigación.					X
10	METODOLOGÍA: El instrumento tiene relación con la matriz de consistencia.					X
CONTEO TOTAL DE MARCAS		A	B	C	D	E

III.- COEFICIENTE DE VALIDEZ

$$\text{Coeficiente de Validez} = \frac{(1 \times A) + (2 \times B) + (3 \times C) + (4 \times D) + (5 \times E)}{50} = 0.98$$

IV.- PROMEDIO DE LA VALORACIÓN

Categoría		Intervalo
Desaprobado		[0,00 – 0,60]
Observado		<0,60 – 0,70]
Aprobado	X	<0,70 – 1,00]

PUNTAJE	0.98	CALIFICACIÓN	Aprobado
FECHA		FIRMA DEL EXPERTO	
14 de julio de 2025		 Dr. Glenn Alberto Lozano Zanelly Médico-Cirujano CMP 23478 Doctor en Educación Doctor en Medicina	

FICHA PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTO)

I.- DATOS GENERALES:

Nombres y Apellidos del Experto: **DR. NICANOR RUBÉN CABEZAS ONOFRIO**

Nombre del instrumento de evaluación: **CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2025**

Autora del Instrumento: **KATHERINE SUSAN RUFASO GOCHE**

Título de la Investigación: **"LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA - LIMA 2025"**

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	CRITERIOS	Puntaje				
		1	2	3	4	5
1	CLARIDAD: El instrumento esta formulado con lenguaje apropiado.					X
2	OBJETIVIDAD: El instrumento propuesto permitirá alcanzar el objetivo planteado en el estudio.					X
3	ACTUALIDAD: El instrumento propuesto es adecuado al avance de la ciencia y tecnología.					X
4	PROPÓSITO: Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.					X
5	SUFICIENCIA: Los ítems del instrumento comprenden los aspectos de cantidad y calidad.					X
6	ORGANIZACIÓN: El instrumento tiene una organización lógica y secuencial.					X
7	CONSISTENCIA: El instrumento comprende aspectos que son investigables.					X
8	COHERENCIA: El instrumento es adecuado para valorar el objeto de investigación.					X
9	INTENCIONALIDAD: El instrumento permitirá dar respuesta al problema de investigación.					X
10	METODOLOGÍA: El instrumento tiene relación con la matriz de consistencia.					X
CONTEO TOTAL DE MARCAS		A	B	C	D	E

III.- COEFICIENTE DE VALIDEZ

$$\text{Coeficiente de Validez} = \frac{(1 \times A) + (2 \times B) + (3 \times C) + (4 \times D) + (5 \times E)}{50} = 1.00$$

IV.- PROMEDIO DE LA VALORACIÓN

Categoría		Intervalo
Desaprobado		[0,00 – 0,60]
Observado		<0,60 – 0,70]
Aprobado	X	<0,70 – 1,00]

PUNTAJE	1.00	CALIFICACIÓN	Aprobado
FECHA		FIRMA DEL EXPERTO	
10 de julio de 2025		 Dr. Nicanor Rubén Cabezas Onofrio Licenciado en Pedagogía y Humanidades, Filosofía y Ciencias Sociales CPPP 0901582198 Doctor en Educación	

FICHA PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTO)

I.- DATOS GENERALES:

Nombres y Apellidos del Experto:	DR. ISRAEL ROBERT PARIAJULCA FERNÁNDEZ
Nombre del instrumento de evaluación:	CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA 2025
Autora del Instrumento:	KATHERINE SUSAN RUFASO GOCHE
Título de la Investigación:	"LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA - LIMA 2025"

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

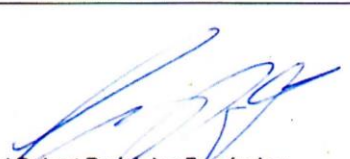
N°	CRITERIOS	Puntaje				
		1	2	3	4	5
1	CLARIDAD: El instrumento esta formulado con lenguaje apropiado.					X
2	OBJETIVIDAD: El instrumento propuesto permitirá alcanzar el objetivo planteado en el estudio.					X
3	ACTUALIDAD: El instrumento propuesto es adecuado al avance de la ciencia y tecnología.					X
4	PROPÓSITO: Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.					X
5	SUFICIENCIA: Los ítems del instrumento comprenden los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6	ORGANIZACIÓN: El instrumento tiene una organización lógica y secuencial.					X
7	CONSISTENCIA: El instrumento comprende aspectos que son investigables.					X
8	COHERENCIA: El instrumento es adecuado para valorar el objeto de investigación.					X
9	INTENCIONALIDAD: El instrumento permitirá dar respuesta al problema de investigación.					X
10	METODOLOGÍA: El instrumento tiene relación con la matriz de consistencia.					X
CONTEO TOTAL DE MARCAS		A	B	C	D	E

III.- COEFICIENTE DE VALIDEZ

Coeficiente de Validez = $\frac{(1 \times A) + (2 \times B) + (3 \times C) + (4 \times D) + (5 \times E)}{50} = 0.98$

IV.- PROMEDIO DE LA VALORACIÓN

Categoría	Intervalo
Desaprobado	[0,00 – 0,60]
Observado	<0,60 – 0,70]
Aprobado	X <0,70 – 1,00]

PUNTAJE	0.98	CALIFICACIÓN	Aprobado
FECHA	FIRMA DEL EXPERTO		
16 de julio de 2025	 Dr. Israel Robert Pariajulca Fernández Cirujano Dentista COP 28782 Maestro en Salud Pública Doctor en Salud		

ANEXO N° 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO

TITULO:

“LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA”

PROPOSITO

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. El estudio busca evaluar la calidad del servicio brindado en el Centro de Salud y su relación con el nivel de satisfacción de los pacientes, con el fin de identificar áreas de mejora en la atención pública.

PROCEDIMIENTOS

Si aceptas participar en el estudio y firmas este consentimiento, en esta “visita” sucederá lo siguiente:

Se le pedirá responder preguntas en una encuesta, esta será de carácter anónimo, donde en el caso de obtener correos, estos se borrarán luego de obtenida la muestra deseada. Las preguntas estarán orientadas a conocer tu experiencia como paciente en el centro de salud, considerando aspectos como el tiempo de espera, la atención recibida, la empatía del personal y las condiciones del lugar.

RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES

Riesgos a la Privacidad y Confidencialidad:

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación, por lo tanto, serán anónimas y se manejarán solo por el investigador a cargo
Cada respuesta será registrada mediante un código numérico, lo que garantiza el anonimato del paciente. Estos datos serán manejados exclusivamente por la investigadora

Encuesta:

Otros:

- **BENEFICIOS QUE SE ANTICIPAN PARA LOS PARTICIPANTES**

Su participación contribuirá al avance del conocimiento en el área de la Gestión Estratégica Empresarial, apoyando el desarrollo de una investigación académica. Además, al responder la encuesta, podrá reflexionar sobre aspectos relevantes de su entorno laboral u organizacional. La participación en este estudio permitirá a los pacientes aportar a una investigación académica orientada a mejorar los servicios de salud. Al responder la encuesta, podrán reflexionar sobre su experiencia como usuarios.

- **BENEFICIO QUE SE ANTICIPAN PARA LA SOCIEDAD. _**

Esta investigación busca generar conocimiento útil que pueda ser aplicado en el ámbito empresarial. Los hallazgos podrían beneficiar a organizaciones públicas y privadas mediante la identificación de buenas prácticas y áreas de mejora, contribuyendo así al desarrollo económico y profesional de la sociedad. Además, los resultados servirán como referencia para futuras investigaciones académicas en el campo de la Gestión Estratégica Empresarial.

El estudio tiene como finalidad generar conocimiento valioso sobre la calidad del servicio en centros de salud públicos. Los resultados podrían servir como insumo para la toma de decisiones en el ámbito de la salud.

- **ALTERNATIVAS A TU PARTICIPACIÓN**

- **COMPENSACIÓN POR TU PARTICIPACIÓN**

- **POSIBLES PRODUCTOS COMERCIALES**

- **MUESTRAS RESTANTES AL FINAL DEL ESTUDIO**

- **INFORMACIÓN GENÉTICA EN TUS MUESTRAS**

- **INFORMACIÓN FUTURA SOBRE EL ESTUDIO**

- **OBLIGACIÓN FINANCIERA**

- **ATENCIÓN DE EMERGENCIA**

- **PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD**

- **LA ELECCIÓN DE PARTICIPAR**

- **NUEVOS RESULTADOS**

- **CONTACTO CON LOS INVESTIGADORES**

Cualquier contacto con la investigadora, se efectuará a los siguientes correos (s):
katherinerufasto23@gmail.com, KATHERINE.RUFASTO@UPSJB.EDU.PE.

• **DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN**

Al participar en este estudio, no estas renunciando a ninguno de los derechos. Si tienes preguntas sobre tus derechos como participante en la investigación, puedes contactarte con el Comité Institucional de Ética de la UPSJB que se encarga de la protección de las personas en los estudios de investigación. Allí puedes contactar con el Dr. _____, Presidente del Comité Institucional de Ética de la Universidad Privada San Juan Bautista al teléfono (01) 2142500 anexo 146, o acudir a la siguiente dirección: Vicerrectorado de Investigación, Campus UPSJB, Av. Juan Antonio Lavalle S/N (Ex hacienda Villa), Chorrillos, Lima.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

He leído (o alguien me ha leído) la información provista arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido contestadas satisfactoriamente. He recibido una copia de este consentimiento, además de una copia de los Derechos de los Participantes en la Investigación.

AL FIRMAR ESTE FORMATO, ESTOY DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN FORMA VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACION QUE AQUÍ SE DESCRIBE.

Nombre del participante

Firma del Participante

Fecha

Lima, 9 de septiembre de 2025

Carta N° 055-2025-EPG-UPSJB

**ESTIMADO DIRECTOR GENERAL
DR. PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO**

Presente. –

Sirva la presente para saludarlo cordialmente a nombre de las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista.

En esta oportunidad presento a Usted, a la bachiller **KATHERINE SUSAN RUFASTO GOCHE**, estudiante del Programa de **MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL**, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista, quien ejecutará el proyecto de Tesis titulado: **“LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA - LIMA 2025”**, el cual será autofinanciado por la investigadora.

Conocedora de su espíritu colaborador en el desarrollo de la presente Investigación, solicito su valioso apoyo en la ejecución del trabajo mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento y consideración.

Cordialmente,



Dra. Sofía Romero Coz
Directora (e) de la Escuela de Posgrado
Universidad Privada San Juan Bautista

CC
Archivo
Coordinación General Académica

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA N°1773-2025-CIEI-UPSJB

El Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, deja constancia que el Proyecto de Investigación detallado a continuación fue **APROBADO** por el CIEI:

Código de Registro: **N°1773-2025-CIEI-UPSJB**

Título del Proyecto: **“LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA - LIMA 2025”**

Investigador (a) Principal: **RUFASTO GOCHE KATHERINE SUSAN**

El Comité Institucional de Ética en Investigación, considera que el proyecto de investigación cumple los lineamientos y estándares académicos, científicos y éticos de la UPSJB. De acuerdo a ello, el (la) investigador (a) se compromete a respetar las normas y principios de acuerdo al Código de Ética En Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social.

La aprobación tiene vigencia por un período efectivo de **un año** hasta el **23/08/2026**. De requerirse una renovación, el (la) investigador (a) principal realizará un nuevo proceso de revisión al CIEI al menos un mes previo a la fecha de expiración.

Como investigador (a) principal, es su deber contactar oportunamente al CIEI ante cualquier cambio al protocolo aprobado que podría ser considerado en una enmienda al presente proyecto.

Finalmente, el (la) investigador (a) debe responder a las solicitudes de seguimiento al proyecto que el CIEI pueda solicitar y deberá informar al CIEI sobre la culminación del estudio de acuerdo a los reglamentos establecidos.

Lima, 23 de agosto de 2025.

Dr. Luis Alberto Barboza Zelada
Presidente del Comité Institucional
de Ética en Investigación